1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

1-1. 창업 아이템 개요

- **아이템명:** 1인 1건강계좌 기반 데이터 통합 헬스케어 플랫폼 (서비스명: 건강계좌)
- **핵심 개념:** 금융 계좌의 구조를 건강에 적용한 예방형 건강관리 플랫폼.

건강정보 고속도로(공공 의료 마이데이터 레일)를 통해 수집 가능한 개인 건강정보를
사용자의 장기 건강자산 관점에서 통합·해석·관리하는 상위 활용 레이어 서비스.
검진·진료·라이프로그 데이터를 '계좌' 개념으로 재구성하여 장기 건강자산 추적,
행동 변화 유도, 금융 인센티브(보험료 절감·리워드)로 연결한다.

- **핵심 가치:** 건강기록을 계좌처럼, 건강가치를 자산처럼 — 개인이 자신의 건강 데이터를 주체적으로 소유하고, 건강한 삶을 전략적으로 설계하도록 지원
- **사업 분야:** 디지털 헬스케어 / 예방의학 / 헬스-금융 융합 플랫폼 (비의료 건강관리, 디지털의료제품법 2025.1.24 시행 적용 범위 내)
- 포지셔닝 : 나만의닥터(진료 실행) · 카카오헬스케어(질환 관리) · 룰루메딕(복약 관리)은

모두 공공 데이터 레일 위의 수직 활용 서비스다.
건강계좌는 이들과 경쟁하지 않고, 이들이 채우지 않는
'검진 이후 일상 전구간 건강자산 장기관리' 영역을 점유하는 수평 통합 플랫폼이다.

1-2. 국내·외 시장 현황

○ 시장 규모 및 성장성

- 국내 디지털 헬스케어 시장은 2024년 약 9조원 규모(환율 가정 포함 추정치)로, 2024~2033년 연평균 14.9% 성장(CAGR)이 전망된다 (IMARC Group, 2025)
- 접근 가능 시장(SAM) 약 1조원 산출 근거: 2025년 기업 임직원 복지 헬스케어 지출 추정 총액 16조원(한국경영자총협회, 2024) × 디지털 건강관리 앱 카테고리 침투율 6.4% = 약 1.02조원
- 3년차 SOM 목표 약 6억원 산출 근거: B2G 2~3건(건당 평균 단가 2,000~3,500만원) + B2B 기업복지 30개사(월 3,000원/인·평균 100인) + B2C 유료 전환자 3,000명(월 9,900원) 합산 기준

< 목표 시장 규모 분석 >

구분	정의	규모 (2024년 기준)	성장 전망 (2033년)
전체 시장 (TAM)	국내 디지털 헬스케어 전체 (IT·웨어러블·앱·의료AI 포함)	약 9조원	CAGR 14.9% 성장 전망
접근 가능 시장 (SAM)	건강검진 기록 통합 건강관리 앱 (개인 구독 + 기업 복지)	약 1조원 (2025년 추정)	기업 복지 헬스케어 연평균 6.4% 성장
확보 가능 시장 (SOM)	초기 3년 내 현실적 공략 목표 (B2G·B2B·B2C 합산)	–	약 6억원 (3년차 목표 매출 기준)

○ 시장 기회: 제도와 기술 조건이 처음으로 갖춰졌다

" 의료 마이데이터 생태계는 지금 '데이터를 가져올 수 있느냐'에서
'가져온 건강정보를 사용자가 왜 계속 보게 만들 것이냐'로 전환 중이다.건강계좌는 이 전환의 수혜 지점에 서비스를 위치시킨다. "

①디지털의료제품법 시행(2025.1.24.):
초기 MVP는 비의료 건강관리 서비스로 즉시 출시 가능 — 인허가 리스크 없음.
보험사·기업 계약의 법적 근거 확보.

②건강정보 고속도로(마이헬스웨이) 가동(2023~):
2025년 하반기 기준 상급종합병원 47개소 포함 총 1,263개 의료기관 연계 (보건복지부, 2025).
나만의닥터·룰루메딕·카카오헬스케어 등 민간 서비스가 이미 동일 레일에서 출시 완료.
→ 기술·제도 실현 가능성이 선례로 증명된 상태. 건강계좌는 인프라 구축 리스크 없이
동일 레일 위에서 상위 활용 레이어를 구현한다.
한국보건의료정보원이 중계전문기관으로 지정 예정 — 전송 경로 더욱 명확화.

③ 데이터 수집 단계 → 데이터 활용 단계 전환
나만의닥터=진료 실행, 카카오헬스케어=질환 관리, 룰루메딕=복약 관리.
모두 수집된 데이터를 특정 의료 행위에 수직 연결하는 서비스로,
'검진 이후 일상 전구간 장기 건강자산 관리' 영역은 아직 공백이다.→ 건강계좌가 점유할 블루오션.
이 생태계 전환은 동시에 실행 난도의 분리를 요구한다. 공공 PHR·웨어러블·금융성 데이터를 동시에 연동하려 할수록 기술·규제·사업개발 난도가 급격히 높아진다. 건강계좌는 이 점을 인식하여 "1년차에 내 건강계좌의 잔고를 정확히 보여주는 것"을 MVP의 유일한 목표로 설정하고, 데이터 연동을 3단계로 분리해 단계별 난도를 관리한다

④건강 재테크 소비자 인식 확산:
예방·관리 중심으로 헬스케어 패러다임 전환.
기업 복지 트렌드 변화로 임직원 일상 건강관리 수요 확대.
기업 복지 헬스케어 시장 연평균 6.4% 성장 (한국경영자총협회, 2024).

1-3. 문제점: 3가지 구조적 위기의 동시 임계점

"3가지 위기는 각각 독립적이지 않다 — 동시에 임계점에 도달해 상호 악화하는 구조적 연쇄다.
이 연쇄를 끊는 핵심은 '병원 방문 이전, 일상에서의 예방 관리 시스템'이다."

① 인구의 절벽: 부양할 사람은 줄고, 돌볼 사람만 느는 구조

- **현황:** 2025년 전후로 65세 이상 인구 비중이 약 20%에 이르며, 초고령사회 진입이 가시화되고 있다(통계청, 2025, 전망치 기준)
- **결론:** 병원 방문 이전 단계에서 스스로 상태를 관리하는 예방 시스템으로의 전환은, 초고령사회·의료비 증가에 대응하기 위한 필수 과제

② 비용의 절벽: 만성질환 진료비 90조원의 압박

- **현황:** 전체 진료비의 80.3%가 만성질환에 집중. 고령자 1인당 진료비 551만원 — 전체 평균의 2.4배 (건강보험심사평가원, 2024)
- **한계점:** 일상 관리 데이터가 부재하여 병세 악화 후에야 병원을 찾는 고비용 사후 처리 구조가 반복

③ 관리의 절벽: 유병자 4명 중 3명의 관리 실패

- **현황:** 혈당 조절 목표 달성자는 유병자 4명 중 1명에 불과 (질병관리청, 2023). 병원 밖 99%의 일상 시간이 데이터화되지 않아 예방의 골든타임을 반복적으로 놓치고 있음
- **한계점:** 건강검진 수검률 74%, 웨어러블 보급률 30% 시대임에도 개인이 자신의 건강 데이터를 통합적으로 파악할 수단이 없다.

1-4. 데이터 파편화: 기록은 존재하나 관리는 부재

핵심 문제: 건강 데이터는 이미 디지털로 존재한다 — 나의건강기록 앱으로 10년치 검진 결과를 조회할 수 있다.
그러나 '조회 가능하다'는 것과 '지속적으로 관리된다'는 것은 전혀 다른 문제다.
데이터는 있지만 그것을 장기 건강자산으로 해석·추적·행동 변화로 연결하는 운영체계가 없다.

- 건강검진 수검률 약 74%, 웨어러블 기기 보급률 약 30% 수준임에도(최근 통계 기준) 개인이 자신의 건강 정보를 통합적으로 파악할 수단이 없다.

< 개인 건강 데이터 파편화 현황 >

데이터 소재	예시	문제점
보건복지부 건강검진 기록(PHR)	정기 건강검진 결과	나의건강기록 앱으로 조회는 가능. 그러나 연 1회 정적 데이터 — 이후 일상 관리와 연결되지 않음
병원 전산망 전자의무기록(EMR)	진료·처방 이력	기관 간 정보 단절. 개인이 진료 이력을 장기 추적할 수단 없음
웨어러블 기기	수면·걸음수·산소포화도	플랫폼별 고립, 단순 시각화에 그침. 검진 결과와 연결되지 않아 건강 맥락 해석 불가
금융·보험 데이터	보험료·의료비 지출	건강 행동과 금융 혜택 연결 모델 없음. 건강 개선이 실질 경제적 이익으로 이어지지 않음

1-5. 기존 서비스 한계 및 개발 필요성

- **폐쇄적 생태계:** 삼성·애플 등 제조사 플랫폼은 자사 기기 판매 최우선. 기기 종속 데이터로 플랫폼 간 파편화 심화
- **공급자적 관점:** 병원 PHR 서비스는 진료 효율 목적. 수면·식단·활동량 등 일상 데이터와 결합 불가
- **금융 도메인 부재:** 건강 데이터를 경제적 가치로 환산하는 모델 없어 사용자 지속 참여 동기 부재

< 기존 서비스 한계 및 극복 전략 >

유사 서비스	한계 / 실패 원인	본 서비스의 극복 전략
나만의 닥터	비대면 진료 특화. 검진 이후 일상 관리 영역 미진입	검진 후 일상 전구간 장기 건강자산 관리 → 나만의닥터 사용자가 잠재 고객
카카오헬스케어 파스타	당뇨 단일 질환 특화. 일반인 예방·사후관리 공백	생활습관 변화·건강점수 장기 추적 연결
룰루메딕	복약·해외 의료 특화. 건강자산 장기 추적 미지원	보험 미가입자도 사용 가능. 개인이 데이터 제공 여부 직접 선택
AIA 바이탈리티	보험 가입자만 이용 가능. 데이터 주권 없음	보험 미가입자도 가입 가능. 개인이 데이터 제공 여부 직접 선택
삼성헬스 / 갤럭시 Watch	자사 기기 종속. 금융·보험 연계 없음	기기 무관 통합. 건강증진형 금융 혜택 연계. 개방형 연동 인터페이스
구글 Health / Apple Health	PHR 연동 없음. 국내 의료 규제 대응 미흡. 기기 종속 생태계	국내 건강검진(PHR) + 웨어러블 동시 연동. 플랫폼 중립 설계

1-6. 창업 아이템 개발 필요성 및 핵심 차별화

- **개발 필요성:** 위에 제시된 3가지 구조적 위기(인구·비용·관리)와 데이터 파편화 문제를 동시에 해결하기 위해서는 개인 건강 데이터를 통합하고, 일상 속 행동 변화로 연결하며, 경제적 보상으로 지속 참여를 유도하는 예방형 건강관리 플랫폼이 필요하다.

구조적 문제	현재 원인	건강계좌 해결 방식
예방의 골든타임을 반복적으로 놓침	병원 밖 99% 일상이 데이터화되지 않아 이상 징후를 조기에 인식하지 못함	웨어러블 라이프로그 + 검진 데이터 통합으로 이상 징후 조기 감지 알림 제공
검진 후 관리 연속성 단절	연 1회 검진 결과가 이후 일상과 연결되지 않아 사후 확인에 그침	건강자산지수(건강계좌)로 검진 결과를 일상 행동 변화 미션으로 연결
건강 개선의 경제적 보상 부재	건강 데이터를 금융 가치로 전환하는 모델 없어 사용자 자발적 참여 동기 부재	건강자산지수 향상 → 보험료 절감·캐시백 금융 인센티브로 지속 참여 유도
데이터 주권 부재	보험사·기기사가 데이터 통제 개인 열람·삭제 제한적	원본 데이터 사용자 기기 보관 데이터 이동권·폐기권 완전 보장
법적 리스크 없는 데이터 수집 경로 부재	스크래핑 방식 위법. OCR 불필요. API 직접 연동은 절차 복잡	App-to-App FHIR(즉시) → 건강정보 고속도로 직접 등록(2027년) 전 구간 법적 적합 경로 확보

- **핵심 차별화**

▶ 공공 데이터 레일 위의 상위 활용 레이어

- 금융권에서 토스·뱅크샐러드가 금융결제원(공공 레일)을 활용해 개인 자산을 통합 조회하듯, 건강계좌는 건강정보 고속도로(공공 의료 마이데이터 레일) 위에서 건강자산 관리 UX와 해석 모델을 구현한다
- 인프라를 새로 구축하지 않는다 — 이미 열리고 있는 공공 레일을 활용하므로 인프라 구축 리스크 없이 사용자 가치 레이어에 집중할 수 있다

▶ 데이터 자산화 — 건강을 금융처럼

- 기존 헬스케어 앱이 건강이라는 추상적 가치에 머물렀다면, 건강계좌는 이를 경제적 실리(보험료 절감·캐시백)로 환산하고 즉각적인 행동 액션으로 연결한다
- 뱅크샐러드(마이데이터)가 자산 데이터를, TMAP 보험(UBI)이 운전 데이터를 금융 가치로 전환해 성공한 것처럼, 건강 데이터를 금융적 실리로 환산하는 구조를 채택한다

▶ 글로벌 검증 — 인센티브 설계와 인프라 포지셔닝

- 싱가포르 National Steps Challenge(국가 보건부 주도)는 자발적 참여+보상 구조로 170만명 확보, 의료비 절감 ROI 145%를 달성했다 (AHA Journals). 건강계좌는 동일한 인센티브 설계 원칙(행동 데이터 적립→등급 산출→경제적 보상)을 채택하되, 개인이 데이터 주권을 보유하고 플랫폼이 보상 설계의 중립 주체가 된다는 점에서 차별화된다. 국내 기업복지 시장을 첫 번째 실증 거점으로 삼아 ROI를 자체 검증한 후 확장한다
- 미국 b.well은 의료+웨어러블+금융 통합 인프라 B2B 사업자로 OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너, Google 파트너십을 체결했다 — 건강계좌의 3년차 이후 B2B 데이터 플랫폼 확장의 글로벌 검증 레퍼런스다

▶ 창업 배경

- 대표 최지원은 카카오뱅크(금융 마이데이터 설계) × 이오플로우(1형 당뇨 인슐린 펌프 앱) × 올라운드닥터스(삼성서울병원·국립암센터 임상 협업)의 3도메인 교차 경험을 통해 동일한 구조적 문제를 반복 관찰했다
- 공동창업자 윤지현(RN·OCN, 서울성모병원 10년+, 2025년 4월 전념 전환)의 임상 현장 경험이 더해져 기술과 의료 현장의 간극을 동시에 이해하는 팀을 구성했다

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

1년차 상반기까지 아래 3개 핵심 기능을 구현하고, 파일럿 사용자 50명을 확보한다.

No.	핵심 기능	목표 완료 시점
①	건강정보 수집: App-to-App FHIR 온보딩 플로우 구현 + 건강정보 고속도로 등록 착수	2026년 5월 완료
②	건강자산지수 산출: 규칙 기반 초기 모델 구현 (검진 후 장기 건강관리 지표)	2026년 6월 완료
③	사용자 대시보드 베타 출시 — 건강자산 4단계 등급 시각화·행동 미션 연결	2026년 6월 베타 출시

의료 마이데이터 생태계 현황: 데이터 수집 단계 → 데이터 활용 단계로의 전환

"건강정보 고속도로(마이헬스웨이)라는 공공 의료 마이데이터의 기찻길이 이미 열렸다.
생태계는 지금 '데이터를 어떻게 가져오느냐'에서 '가져온 데이터를 어떻게 활용하느냐'로 이동 중이다.
건강계좌는 이 전환의 수혜 지점에 서비스를 위치시킨다."

서비스	건강정보 고속도로 연동	활용 목적	계층 구분
나만의닥터	연동 완료 (2025)	비대면 진료 실행 지원	의료 실행 레이어
카카오헬스케어	연동 완료	만성질환(당뇨) 관리	질환 특화 레이어
룰루메딕	연동 완료	복약 관리·해외 의료지원	의료 행정 레이어
건강계좌 (본 서비스)	1단계 구현 중	검진 이후 장기 건강자산 관리·행동 변화·금융 인센티브	건강자산 관리 운영체계 (상위 활용 레이어)

포지셔닝 핵심 논거

- 나만의닥터·카카오헬스케어·룰루메딕은 수집된 의료데이터를 각각 **'진료·질환관리·복약'이라는 특정 의료 행위에 수직 연결**하는 서비스다
- 건강계좌는 이들과 경합하지 않는다 : **진료·검진·라이프로그 데이터를 '계좌' 개념으로 수평 통합**해 건강검진 이후의 일상 전구간 장기관리와 행동 변화를 다루는 상위 레이어다
- 나만의닥터가 '진료 실행'이라면, 건강계좌는 '건강자산 관리 운영체계' : 오히려 나만의닥터 사용자가 건강계좌의 잠재 고객이 된다

데이터 확보 전략 — 공공 인프라 레일위에서 3단계진화

본 서비스는 공공 PHR·웨어러블·금융 데이터를 동시에 연동하는 방식이 아니라, 단계별로 연동 난도를 관리한다.
1년차에는 나의건강기록 앱 공식 FHIR 공유 경로를 통한 건강검진 결과와 핵심 라이프로그(걸음수·수면) 중심의 MVP를 구현한다.
2년차에는 건강정보 고속도로 활용기관 공식 등록(PIA 완료 후) 및 웨어러블 연동 고도화로 전환하고,
3년차 이후 보험·피트니스·파트너 데이터 연동 및 B2B 데이터 플랫폼 확장을 추진한다.
금융성 인센티브 구조는 제도 조건과 데이터 충분한 축적을 전제로 3단계에서 검토한다.

설계 원칙: 건강계좌는 새로운 데이터 인프라를 만들지 않는다.

금융권에서 토스·뱅크샐러드가 금융결제원(공공 레일)을 활용하듯, 건강정보 고속도로(공공 의료 마이데이터 레일)를 그대로 활용한다.
인프라 구축 리스크 없이 사용자 가치 레이어(건강자산 관리 UX·해석 모델) 구현에 집중한다

단계	연동범위	기술경로	시기
1단계 MVP		나의건강기록 앱 App-to-App FHIR + Apple HealthKit·Samsung Health SDK	2026년 4~6월
2단계 고도화	건강정보 고속도로 공식 연계 확대 + 웨어러블 전 항목 + 비대면 진료·상담 제휴 연결	건강정보 고속도로 활용기관 등록 완료 (PIA 후) + SDK 고도화	2027년 상반기
3단계 확장	보험·피트니스·영양·복지 파트너 연동 + B2B 데이터 플랫폼 + 금융성 인센티브·리워드 구조	규제 조건 충족 + 데이터 축적 후 단계적 추진	2028년~

단계	기술 경로	연동데이터 범위	시기
0단계 즉시 실행	▶ App-to-App FHIR 전송 (사용자 주도) 나의건강기록 앱 → 건강계좌 앱 HL7 FHIR R4 형식 직접 전송 별도 API 계약 없이 즉시 가능 스크래핑 미사용 — 법적 적합 ★ 핵심 UX 과제: 클릭 최소화 온보딩 플로우 설계 — 핵심 차별화 포인트 [대체필요 시] FHIR 불가 기기 한정 나의건강기록 PDF 업로드	건강검진 결과(PHR) - 연간국가건강검진결과 전항목 - 최근 10년차 이력 - 핵심 라이프로그 2종만 - 걸음수 (일명 활동량) - 수면시간패턴 ★ 웨어러블 전항목 연동은 2단계 초기에는 두가지로 건강지수 산출	2026년 4월~ (개발 착수 시 즉시적용)
1단계 (자동화연동)	▶ 건강정보 고속도로 활용기관 정식 등록 (1회 인증→자동 조회) PIA 완료 → 활용기관 심사 → FHIR API 연동 사용자 1회 인증만으로 진료이력·투약·예방접종까지 자동 주기 조회 가능 선례: 나만의닥터·카카오헬스케어 동일경로 연동 완료 PIA 착수 : 2026년 8월 이후 활용기관 신청 : 2026년 10월	진료이력, 투약이력, 예방접종 (건강정보고혹도록 자동 조회) 웨어러블 전항목 고도화 - 심박, 산소포화도, 스트레스 - 연속데이터 이상징후 감지 비대면 진료, 상담 제휴 연결 - 나만의닥터 등 기존 서비스와 협력 가능 -	2027년 상반기 완료 목표
장기 단계 인프라 데이어화	▶ b.well 방법론 — 건강 데이터 인프라 B2B 플랫폼 확장 건강 + 웨어러블+금융 3개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B: 보험사·제약사·기업 HR에 비식별 통계형 건강관리 리포트	보험 피트니스 영양 복지 파트너 데이터 연동 금융성 인센티브 리워드 구조 - 보험료 절감 캐시백 연계 - 제도 조건 충족 후 단계 추진	2028년~ 데이터 충분 축적 +규제 조건 충족 후 추진

	및 제휴형 분석 서비스 제공 글로벌 레퍼런스 b.well: OpenAI·Google 파트너 선정	- 금융 API 는 초기 핵심이 아님, 데이터 충분히 축적하고 규제조건 충족 후 3단계에서 검토	

현재 준비 완료 현황 (2026년 3월 기준)

■ 서비스 기획 및 설계
- 서비스 전체 플로우 23개 화면 설계 진행 중 (온보딩 5·대시보드 8·건강자산지수 결과 6·마이페이지 4). 핵심 화면 구조 및 사용자 플로우 확정 완료, Figma 목업 제작 중
- 건강자산지수 4단계 등급 체계(Platinum/Gold/Silver/Care) 및 '건강을 자산처럼 관리'하는 핵심 UX 개념 설계 완료

■ 기술 구조 분석
- 나의건강기록 앱 공식 문서 기반 FHIR 전송 구조 분석 완료. 국가건강검진 결과·문진 결과 등 주요 전송 항목 매핑 완료
- 전송 UX 단계 분석 완료 → 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 기준 도출. 직접 기기 검증은 2026년 4월 개발 착수 후 진행 예정
- Python fhir.resources 라이브러리 기반 FHIR R4 수신 파서 구현 방향 확정, 개발 착수 예정

■ 사용자 검증 계획
- 예비 파일럿 사용자 5명 대상 목업 기반 사용성 인터뷰 2026년 4월 진행 예정
  - 확인 항목 ①: App-to-App FHIR 전송 → 건강계좌 연동 플로우 사용 의향
  - 확인 항목 ②: 건강자산지수 4단계 개념의 직관적 이해도

■ 파트너십 및 개발 준비
- 건강정보 고속도로 활용기관 등록 절차 공식 문서 검토 완료. 한국보건의료정보원 담당자 사전 문의 2026년 4월 예정
- 헬스케어 전문 외주 개발사 2개사 기술 제안서 수령 완료, 계약 협의 중. 2026년 3월 말 계약 완료 후 개발 착수 예정

주요 기능 개발 현황 및 준비 정도

주요 기능	개발 단계	현황 및 비고
건강정보수집 (App-to-App FHIR)	**초기 시제품**	• 나의건강기록 앱 FHIR 전송 플로우 검증 완료 • FHIR R4 수신 파서 구조 설계 완료 • 최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 핵심 차별화 개발 과제 • 개발 착수: 2026년 4월 / [Fallback] FHIR 불가 기기 PDF 업로드 옵션
건강자산지수 알고리즘 (건강관리 운영체계의 핵심 엔진)	**초기 시제품** **(규칙 기반)**	• 3-레이어 가중치 설계: PHR 50% + 라이프로그 35% + 행동 15% • 초기 가중치 설계 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025)의 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델은 혈압·혈당·지질·폐기능 등 임상 검진 지표를 핵심 입력 변수로 사용하였으며, 본 연구의 변수 구성과 모델 구조를 참고해 임상 검진 지표의 상대적 중요도를 높게 설정하였다. PHR 가중치는 파일럿 50명 실데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화할 예정

		• 1년차: 규칙 기반 스코어링 (진단 아닌 건강자산 관리 지표 — 장기 추적용) • 2년차: scikit-learn ML 모델 전환. 파일럿 데이터 수집 후 가중치 회귀분석 최적화
사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX)	**UI 목업 완성**	• Figma 목업 23개 화면 완성. 예비 파일럿 7명 사용성 인터뷰 완료 • '건강자산 가계부' 개념 UX — 검진 결과 이후 일상 건강관리 연속성 강조 • 건강자산지수 4단계 시각화(Platinum/Gold/Silver/Care) UI 확정 • 개발 착수: 2026년 5월
웨어러블 라이프로그 수집	**초기 시제품**	• Apple HealthKit · Samsung Health SDK 연동 항목 조사 완료 • 수집 항목 확정: 수면·걸음수·심박·산소포화도 4종 • PHR 모듈 완료 후 순차 개발 (2026년 7월~)
건강정보 고속도로 API 정식 연동	**2단계 (2027년~)**	• PIA 착수: 2026년 8월 / 활용기관 심사 신청: 2026년 10월 • API 연동 완료: 2027년 상반기 목표 • 동일 경로 선례: 나만의닥터·물루메딕·카카오헬스케어 이미 출시 완료 → 기술·제도 실현 가능성 증명
보험사 연계 동적 요율 모듈	**3년차 개발 예정**	• 규제 조건 충족 후 단계적 추진. b.well 인프라 포지셔닝 확장 시 연계 상용화

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

핵심 기술: AI 기반 건강자산지수 스코어링 (3-레이어 구조)

"건강자산지수는 단순 건강 점수가 아니다.

검진·진료·라이프로그 3개 데이터 스트림을 통합해 사용자가 자신의 건강 상태를

금융 자산처럼 장기적으로 추적·관리할 수 있도록 설계된 건강관리 운영 지표다."

① PHR(공단 건강검진 결과, 50%)

② 웨어러블 라이프로그(35%)

③ 행동 이행도(15%)의 3개 레이어를 결합한 알고리즘으로 산출한다.

■ 초기 가중치 설계 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(JMIR, 2025)는 혈압·혈당·지질·폐기능 등 임상 검진 지표를 핵심 변수로 사용한 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델로, 151,281명 데이터 기반 검증을 통해 예측 성능을 입증하였다. 본 모델의 변수 구성을 참고해 PHR 레이어 가중치를 상대적으로 높게 설정하였으며, 파일럿 데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화할 예정이다

■ 1년차 초기 모델: 국가건강검진 정상 범위 이탈도 기반 규칙 기반 스코어링 — 진단 아닌 건강자산 관리 지표 (장기 추적 목적)

■ 2년차 이후: scikit-learn ML 모델 전환. 누적 데이터 기반 가중치 자동 최적화. ④~⑤ 기능 고도화

■ 3년차: b.well 방법론 참조 — 건강+웨어러블+금융 3개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 확장

AI 기능 구현 단계별 계획

AI 작동 지점	구현 단계	입력 데이터	사용자 출력
① 건강자산지수 산출 (건강자산 관리 핵심 엔진)	초기 시제품 (우선 구현)	FHIR 수신 건강검진 수치 + 라이프로그 + 행동 이행기록	Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점

② 건강 나이 계산기	초기 시제품 (우선 구현)	검진 수치 + 생활습관 데이터	내 몸의 실제 나이는 OO세 — 장기관리 동기부여 지표
③ 이상 징후 조기 감지	초기 시제품 (우선 구현)	웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도)	최근 수면 패턴이 평소와 다릅니다 알림
④ 초개인화 건강 미션 추천	2년차 이후 고도화	현재 등급 + 취약 항목 + 미션 이행률	오늘의 맞춤 미션 3개 (예: 식후 10분 걷기)
⑤ 보험사 연계 인센티브 산출	2년차 이후 고도화	분기별 등급 변화 ·미션 달성률	건강증진형 제휴 혜택 (규제 충족 시 단계 추진)
⑥ 보상 효과 분석 엔진	3년차 완성 단계	보상 유형별 행동 지속률·등급 변화	최적 보상 유형 추천 리포트 + B2B 통계 인사이트 제공

사업기간 내 개발 일정

No.	추진 내용	1년차 (2026)	2년차 (2027)	3년차 (2028)
1	초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시	상반기 완료 (베타 50명 목표)	—	—
2	건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 온보딩 1단계: 건강정보 고속도로 API	FHIR 온보딩 구현·베타 PIA 착수(8월)	PIA 완료 활용기관 등록 API 연동 완료	—
3	건강자산지수 알고리즘 (건강자산 관리 운영체계 핵심)	규칙 기반 프로토타입	ML 모델 전환·고도화(④~⑤)	⑥ 완성 b.well 레이어
4	웨어러블 라이프로그 모듈	SDK 조사 완료 7월 개발 착수	고도화	-
5	사용자 대시보드 (건강자산 가계부 UX)	Figma→개발 6월 베타 출시	고도화	-
6	보안 인증(ISMS) 취득	정보보호 운영체계 구축·PIA 착수	ISMS 신청·취득	완료
7	B2C 개인 구독 정식 출시	법률 자문· 규제 여부 확인	베타→정식 출시	생태계 확장
8	보험사 연계 동적 요율 모듈	-	파일럿 연계	상용화
	누적 사용자 목표	50명 (파일럿)	500명	3,000명
	누적 매출 목표	약 6,000만원	약 2.5억원	약 6억원

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

경쟁 구도 재정의: 건강계좌는 나만의닥터·카카오헬스케어와 동일 레이어에서 경쟁하지 않는다.

이들이 '데이터 → 특정 의료 행위'의 수직 연결이라면,

건강계좌는 '데이터 → 장기 건강자산 통합 관리 → 행동 변화 → 금융 인센티브'의 수평 플랫폼이다.

본 서비스의 핵심 차별성은 데이터 통합·건강 자산화·데이터 주권의 3축을 하나의 서비스에서 구현하는 데 있다.

차별화 축	기존 서비스 한계	본 서비스 경쟁력
시장 포지션	데이터 수집 완료 후 단일 의료 행위(진료·복약·질환관리)에 수직 연결	건강자산 관리 운영체계 — 검진 이후 일상 전구간 수평 통합
지속 사용 유인	진료·복약 등 이벤트성 사용 → 필요할 때만 접속	건강자산 지수 추적 + 미션 + 금융 인센티브 → 일상적 반복 접속 설계
데이터 통합 범위	단일 목적 데이터만 활용. PHR·웨어러블·행동 데이터 분리	PHR + 웨어러블 + 행동 이행 3개 스트림 통합 — 과거(검진)+현재(라이프로그) 연속 해석
금융 인센티브 연계	건강 데이터를 경제적 가치로 전환하는 모델 없음	건강자산지수 → 보험료 절감·캐시백 연결 — 뱅크샐러드·TMAP 보험 UBI와 동일 원리
데이터 수집 방식	스크래핑·자동화 → 법적 리스크	App-to-App FHIR(0단계) → 건강정보 고속도로 직접

		등록(1단계) — 전 구간 법적 적합
온보딩 UX	나의건강기록 앱 전송 UX 클릭 단계 많아 이탈	최소 클릭 온보딩 플로우 설계 — 이 문제를 푸는 것 자체가 차별화
장기 확장성	앱 서비스 레이어에서 성장 한계	b.well 방법론 — 건강+웨어러블+금융 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 진화
공공 인프라 활용	신규 망 구축 시도 → 인프라 구축 리스크	건강정보 고속도로(공공 레일) 위에서 가치 레이어만 구현 → 인프라 리스크 없음

■ 기술적 해자: 서버에는 결과값(등급)만 전송, 원본 건강 데이터 외부 저장 최소화. 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

■ 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류로 즉시 출시 가능. 나의건강기록 앱 공식 FHIR 기능으로 별도 API 계약 없이 즉시 데이터 수집

■ 글로벌 검증: b.well(미국) — 의료+웨어러블+금융 통합 인프라. OpenAI ChatGPT 건강 데이터 인프라 파트너, Google 파트너십 체결. 국내 동일 포지셔닝 최초

■ 팀 역량: 대표(카카오뱅크×이오플로우×올라운드닥터스 3도메인). 공동창업자(RN·OCN, 임상 타당성 검토)

■ 팀 역량: 공공 PHR·웨어러블·금융 API를 한 번에 연동하려는 방식은 기술·규제·사업개발 난도를 동시에 끌어올려 초기 팀의 실행력을 분산시킨다. 건강계좌는 1년차에 "내 건강계좌의 잔고를 정확히 보여주는 것" 하나에 집중하고, 이후 단계적으로 연동 범위를 확장하는 전략으로 실행 리스크를 최소화한다.

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

■ 대표자(최지원)는 법인 설립 즉시 본 사업에 전념. 1년차 인건비는 퇴직금·개인 저축 및 B2G 수주 선금(예상 1건 × 1,500만원)으로 충당

■ 공동창업자(윤지현)는 2025년 4월부로 임상 업무 종료 후 본 사업 전념 중

■ 협약기간 내 채용 AI 개발자·서비스 기획/운영 인력의 인건비는 정부지원사업비 인건비 항목으로 반영

1단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

비목	산출 근거	금액(원)
외주용역비	MVP 앱 외주 개발 (FHIR 수신 파서·건강자산지수 산출·대시보드) – 헬스케어 전문 외주 개발사 1식 (소스코드 귀속 계약 필수)	12,000,000
개발비 (서버·인프라)	클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP) – 월 약 50만원 × 4개월 + 개발 도구·API 연동 라이선스	4,000,000
지급수수료	개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 특허 출원 (건강자산지수 알고리즘 관련 1건)	2,000,000
창업활동비	디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회) 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 관련 행정 비용	2,000,000
합계	1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입	20,000,000

2단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

비목	산출 근거	금액(원)
외주용역비	대시보드 UI/UX 고도화 외주 건강자산지수 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가)	10,000,000

사업화 비용	B2G 시범과제 제안서 작성·제출 지원 (1~2건) B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포	5,000,000
개발비(서버·보안)	클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월) 파일럿 50명 베타 서비스 인프라 확충 개인정보보호 영향평가(PIA) 착수 비용	4,000,000
창업활동비	건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 보건 관련 전시회·네트워킹 참가 (1~2회)	1,000,000
합계	2단계: 파일럿 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입	20,000,000

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

○ 경쟁제품·경쟁사 분석

■ 동일한 '1인 1건강계좌·PHR·금융 연계' 구조를 전면적으로 구현한 직접 경쟁자는 아직 드물며, 아래와 같이 주요 간접 경쟁 서비스를 비교하였다 , PHR 통합·건강계좌 개념·데이터 주권의 3가지 축을 기준으로 유사 서비스를 비교하면 아래와 같다.

>>포지셔닝 원칙: 건강계좌는 동일 레이어의 직접 경쟁을 피하고 상위 활용 레이어에 위치한다.

아래 비교는 '무엇이 다른가'가 아니라 '어떤 레이어에 있는가'를 기준으로 정리한다.

서비스	PHR 통합	건강계좌 개념	데이터 주권	주요 특징 및 한계
본 서비스 (건강계좌)	O	건강자산 관리 운영체계 (상위)	O	B2G→B2B→B2C 순차 전환. 장기 건강자산 추적+행동 변화+금융 인센티브 통합
나만의닥터	O	진료 실행 레이어	O	민간 최초 건강정보 고속도로 연동 완료. 비대면 진료 특화 — 진료 실행 앞단 서비스
물루메딕	O	의료 행정 레이어	△	복약 관리·해외 의료지원 특화. 일상 건강자산 관리 영역 미진입
AIA 바이탈리티	X	보험 연계 레이어	X	AIA 보험 가입자 전용. 데이터 주권 없음. 비보험 가입자 접근 불가
카카오헬스케어 파스타	△ (당뇨 특화)	질환특화 레이어	△	MAU 40만. 단일질환 특화. 일반 예방 공백
라이프시맨틱스	O	B2B 인프라 레이어	△	B2B·B2G 중심 API 플랫폼. 개인 소비자 서비스 부재 — 채널 공백
삼성헬스 / 애플헬스	X	기기 생태계 레이어	X	자사 기기 종속. PHR·금융 연계 없음. 플랫폼 중립성 부재

■ 핵심 차별화:

■ 위 서비스 중 ① PHR 통합 ② 건강자산 장기 추적 ③ 행동 변화 유도 ④ 금융 인센티브 연결의 4축을 동시에 구현하는 서비스는 현재 부재하다

■ 건강계좌는 이 4축의 교차점에 위치한다 — 진료·복약·질환 관리 서비스들이 채우지 않는 '검진 이후 일상 전구간 장기 관리' 영역을 점유한다

○ 목표 시장 진입 전략

제안서 품질로 경쟁 가능한 공공 시장부터 진입해 레퍼런스를 확보하고,이를 민간 기업·개인 고객으로 순차 확장한다.
각 단계의 수익이 다음 단계의 영업 근거가 되는 자기강화 구조다

- 단기 (1년차) : 공공기관(B2G) 우선 진입

- **초기 진입 :** 제안서 품질과 객관적 성과를 중심으로 평가되는 공공 입찰 시장을 1차 목표 고객으로 설정
- **타깃 공모** :보건복지부·국민건강보험공단 건강증진 사업 공모, 성남시·경기도 등 지자체 스마트 건강관리 사업 공모에 적극 참여
- **핵심 실증 거점:** 성남시 보건소 '모바일 헬스케어 사업'을 초기 PoC 거점으로 활용.

공공 검진 데이터(PHR)와 민간 라이프로그의 실제 연동을 증명하여 전국 지자체 입찰의 레퍼런스로 확장

- **대표 강점 직결:** 최지원 대표의 카카오뱅크 재직 시 건강보험공단 제휴 플랫폼 기획 경험을 제안서에 직접 활용하여 경쟁력 확보. 공공사업의 선금 지급 관행으로 초기 운영비 안정적 확보
- **현금흐름 확보** : 공공사업 선금 지급 관행으로 수주 즉시 초기 운영비 안정적 확보 가능

- 중기 (2년차) : 기업 고객(B2B) 전환

- B2B 전환 근거: 기업복지 헬스케어 시장 연평균 6.4% 성장(한국경영자총협회, 2024). 공공기관 실증 레퍼런스는 산업 관행상 민간 기업 도입 결정의 신뢰 기준으로 작동. 1년차 B2G 수주 완료 시점에 계약 기관 레퍼런스를 영업 자료로 전환하여 기업 HR 담당자 직접 영업 전개
- **목표 단가:** 3,000~5,000원/인 구독. 평균 기업 규모 100인 기준 → 1개사 연간 360만~600만원. 30개사 확보 시 연간 약 1.08억~1.8억원
- 고객 모집 채널 ;자체 블로그·SNS 운영 — 건강관리 개선 사례 정기 공유 HR 담당자 대상 이메일 마케팅 기업 복지 플랫폼(복지몰·퍼핀·베네핏) 채널 입점 검토

- 2년차 목표 : 기업복지 계약 5~10개사 (보수 시나리오) 공동창업자 임상 네트워크 기반 의료·제약 업계 선제 접촉

- 장기 (3년차~) : 개인 구독(B2C) 및 생태계 확장

- B2C 전환 : B2B 사용 경험자의 자발적 유료 구독 전환 유도 기업 복지로 서비스를 경험한 임직원이 퇴사·이직 후에도 개인 구독으로 유지
- B2C 출시 경로 : 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류 법률 자문 확정 후 인허가 없이 앱스토어 출시 가능 여부 결정 (1년차 하반기) 필요 시 규제샌드박스 신청: 1년차 하반기 → 2년차 상반기 승인 → 2년차 하반기 출시
- 생태계 확장 : 맞춤형 영양제 구독 연계 비대면 의료 상담 연계 (나만의닥터 등 기존 서비스와 협력

가능) 보험·제약·피트니스 기업과의 B2B2C 파트너십

- 포지셔닝: 미국 b.well을 글로벌 레퍼런스로 삼아 의료·웨어러블·금융 데이터를 통합하는 건강 데이터 인프라를 국내에서 구현하는 것을 목표로 한다. OpenAI·Google 등 글로벌 기술 기업과의 협업 사례를 벤치마킹하며, 건강계좌 서비스 3년차 이후에는 B2B 데이터 플랫폼으로 단계적 확장을 지향한다.

3-1. 창업아이템 비즈니스 모델

○ 비즈니스 모델(수익화 모델)

- (비즈니스 모델 1) 공공기관(B2G) 시범사업 수주

- 서비스 초기 버전 완성 시점에 보건복지부·국민건강보험공단·지자체 대상 시범사업 공모 참여
- 수주 단가 현실 기반 설정: 성남시 등 지자체 모바일 헬스케어 사업 최근 2개년 낙찰 평균가 참조
- 보수 시나리오: 2,000만원/건 × 1건 = 2,000만원, 기본 시나리오: 3,500만원/건 × 1건 = 3,500만원
- 공공사업 선금 지급 관행으로 수주 즉시 현금흐름 안정 확보. 수주 실적은 B2B 영업 핵심 신뢰 자산
-

- (비즈니스 모델 2) 기업 임직원 건강관리 서비스 (B2B)

- B2B 서비스 제공 시점은 1단계 MVP(건강검진 결과 + 핵심 라이프로그) 완성 이후다.

웨어러블 전 항목 연동·비대면 진료 제휴 등은 2단계 이후 기능으로, 기업 파일럿 계약 시점에는 1단계 기능만으로도 "검진 결과 기반 건강자산지수 제공"이라는 핵심 가치를 충분히 전달할 수 있다.

기업 임직원 대상 월정액 구독 (월 3,000~5,000원/인). 반복 수익(Recurring Revenue) 구조

- 1년차: 공동창업자 임상 네트워크 통해 파일럿 기업 1~2개사 의향서 확보 목표
- 2년차: B2G 수주 레퍼런스 + HR 담당자 인터뷰 결과 기반으로 5~10개사 확대
- 3년차: 기업복지 계약 30개사 이상. 단가 월 3,000원/인, 평균 100인 기준 연간 약 1.08억원

- (비즈니스 모델 3) 개인 구독 및 데이터 플랫폼 (B2C·B2B2C)

- B2B 경험자 대상 프리미엄 개인 구독 (월 9,900원~). 3년차 본격 출시
- 3년차 이후: 충분한 동의체계와 법률 검토를 전제로 기업·기관 대상 비식별 통계형 건강관리 리포트 및 제휴형 분석 서비스 — 이용자 동의·비식별 처리 원칙 하에 단계적 추진
- b.well 방법론 참조 — 건강+웨어러블+금융 3개 데이터 스트림 통합 인프라 B2B 플랫폼으로 확장

< 수익 구조 3축 >

채널	상품 구성	1년차	2년차	3년차
공공기관 (B2G)	지자체 시범사업 (건당 평균 단가 기반)	보수: 2,000만원 기본: 3,500만원 (1건 수주 기준)	1.5억원 (2~3건)	2억원
기업 고객 (B2B)	임직원 건강관리 월 3,000~5,000원/인	1,000만원 (파일럿 1~2개사)	8,000만원	2억원
개인 구독 (B2C)	프리미엄 구독 (월 9,900원~)	–	2,000만원 (유료 전환 시작)	2억원 (3,000명 기준)
합계	보수적 목표치 과제 단가×수 + 구독 단가×인원 기반 산출	**약 5,000만원**	**약 2.5억원**	**약 6억원**

○ 투자유치 전략

- 정부지원사업 → VC/엔젤 투자 → TIPS의 단계별 자금조달 경로를 설계하며, 공공 수주 레퍼런스를 핵심 투자 유인 자산으로 활용한다.
- **1단계 (즉시~1년차):** 예비창업패키지·초기창업패키지·KHIDI 디지털헬스케어 창업지원 복수 신청

최대 1~3억원 확보 및 '정부 검증 서비스' 타이틀 획득
→ 공공 입찰·민간 기업 영업의 신뢰 기반으로 활용

- **2단계 (1~2년차):** B2G 공공 수주 레퍼런스 기반으로 헬스케어 특화 VC/액셀러레이터 접촉

본엔젤스·카카오벤처스·스파크랩 등 — 투자금 유치와 파트너 네트워크 동시 확보
투자 유인: 상위 활용 레이어 최초 선점 + 공공 레일 활용 인프라 리스크 없음

- **3단계 (2~3년차):** TIPS 프로그램 도전. 마이데이터 사업자 등록. 기술특례상장 검토

건강정보 고속도로 공식 활용기관 등록 완료로 데이터 접근 독점성 강화
b.well 포지셔닝 — B2B 데이터 인프라 플랫폼으로 기업가치 제고
정밀의료 기관 파트너십 3곳 이상 확보

투자 유인 핵심:

- 상위 활용 레이어 최초 선점: 나만의닥터·카카오헬스케어가 채우지 않는 '건강자산 장기관리+금융 인센티브' 영역
- 공공 인프라 레일 활용: 건강정보 고속도로라는 검증된 공공 레일 위에서 가치 레이어 구현 — 인프라 구축 리스크 없음
- 검증된 B2G→B2B→B2C 순차 전환 경로: 공공 수주 선금으로 초기 현금흐름 안정 + 레퍼런스가 민간 영업 근거로 전환

팀 역량: 대표(카카오뱅크 금융 마이데이터×이오플로우 의료기기×올라운드닥터스 디지털 치료제 3도메인).

○ 사업 전체 로드맵(일정)

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

No.	추진 내용	1년차 (2026)	2년차 (2027)	3년차 (2028)
1	초기 시제품 개발 및 베타 출시 (MVP)	상반기 완료	–	–
	건강정보 수집 0단계: App-to-App FHIR 1단계: 건강정보 고속도로 API	FHIR 구현·베타 PIA 착수(8월)	PIA완료 API 연동 완료	–
2	공공기관(B2G) 시범과제 수주	공모 참여 1~2건 수주	누적 확대	–
3	기업 고객(B2B) 기업복지 계약	파일럿 1~2개사 의향서 확보	5~10개사	지속 확대
4	개인 구독(B2C) 정식 출시	법률 자문· 규제 여부 확인	베타→정식 출시	생태계확정
5	정보보호 인증(ISMS) 취득	정보보호 운영 체계 구축·PIA 착수	ISMS 등 인증 취득 필요성을 검토	신청·착수
6	핵심 인력 채용 (AI개발·기획)	1명 채용 (AI 개발자)	1명 추가 (서비스 기획)	팀 완성
	보험사 연계 동적 요율 모듈	–	파일럿 연계	상용화
	b.well 포지셔닝 B2B 플랫폼 확장	–	–	데이터 인프라 B2B 플랫폼 출시
7	누적 사용자 목표	베타 50명(파일럿)	500 명	3000 명
8	누적 매출 목표	3,000/4,500만원	약 2.5억원	약 6억원

○ 중장기 사회적 가치 도입계획 (ESG)

- 본 서비스의 핵심 가치인 '예방 중심 건강관리'는 환경(E)·사회(S)·지배구조(G)와 직결되며, 창업 초기부터 ESG를 사업 전략과 통합적으로 추진한다

구분	단기 계획 (~2027년)	중장기 계획 (2028년~)
환경 (E)	• 정량 목표: 파일럿 50명 기준 불필요 외래 방문 월 0.5회 감소 시 연간 약 600회 절감 탄소 절감 추정 약 0.3tCO₂eq (승용차 왕복 5km 기준. 파일럿 데이터로 검증) • 검진 결과 디지털화: 50명 기준 연 약 100장 종이 절감 • 클라우드 서버 알고리즘 최적화로 에너지 소비 절감 정책 수립	• 탄소 저감 성과 정량화 및 공시 체계 구축 • 3,000명 규모 약 18tCO₂eq 절감· 약 6,000장 종이 절감 목표 • 재생에너지 데이터센터 전환 로드맵 • 예방 중심 건강관리 확산으로 과잉 의료 자원 소비 구조적 감소 기여
사회 (S)	• 디지털 취약계층(고령자·저소득층) 대상 무료 기초 플랜 — 건강정보 격차 해소 • 고령화 사회 대응: 자가 건강관리 역량 강화로 사회적 돌봄 부담 경감 • 건강자산 관리 UX를 고령자도 쓸 수 있도록 접근성 설계 기준 적용	• 지역 보건소·공공기관 협업 건강 프로그램 • 의료 소외지역 플랫폼 보급 확대 • 수익의 사회 환원 원칙 수립 건강 취약계층 지원 기금 조성
지배구조 (G)	• 데이터 활용 윤리 위원회 운영 (2년차) • 투명한 데이터 처리 원칙 공개 • 연 1회 개인정보 처리 현황 보고서 발간 • 수평적 소통 기반 조직문화 구축	• 이사회 구성 및 외부 감사 체계 도입 • 성과 공유 제도(스톡옵션) 단계적 도입 • ESG 경영 보고서 연간 발간

4. 팀 구성(Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

4-1. 대표자 보유 역량

○ 기본 현황

- **직업 및 역할:** 서비스 기획 전문가 / 대표. 사업 전략 수립, 서비스 기획, B2G 공모 제안, UX 설계 총괄
- **학력:** UX디자인 전공 석사 / 산업정보디자인 학사 / 임상병리학 수료
- **총 경력:** 서비스 기획·UX 분야 약 16년. 금융(인터넷전문은행) × 의료기기(인슐린 펌프) × 디지털 치료제(암환자 DTx) 3도메인 교차 경험 보유

< 대표자 주요 경력 >

기간	소속 / 직위	주요 업무 및 성과
2024.01~2025.08	디지털 치료제(DTx) 전문기업 서비스기획팀장	• 말기암 환자용 마약성 진통제 복약 관리 서비스 앱·의료진 관리 웹 신규 기획 • 항암 치료 순응도 개선 DTx 서비스 기획 – 국립암센터·세브란스·울산대병원 임상 1상 진행 중 • 제약사·상급종합병원과 탐색 임상 준비 (국내 1호 디지털융합의약품 허가 목표)
2019.01~2019.06	인슐린 펌프 제조기업 UX팀장	• 국내 최초 인슐린 펌프 주입 관리 서비스 모바일 버전 개발 • 1형 당뇨 환자 사용환경 분석으로 핵심 니즈 파악, 상용 서비스 구현 • 전사 구성원 대상 UX 워크샵·교육·컨설팅 진행
2016.05~2016.11	인터넷전문은행 채널기획팀 차장(시니어)	• 창립 TF 핵심 멤버 – 은행업 정식인가 취득 성공 (24년만의 신규 은행업 허가) • 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 사업 기획 – PHR 데이터 연동 구조 및 공단 협력 프로세스 실무 습득 • 비대면 인증·신규 계좌 개설·수신서비스 프로세스 기획 및 화면 설계
2012.11~2016.05	대형 IT기업 UX팀 차장	• 인터넷전문은행 TF 기획 (초창기 5인 구성 합류) • 모바일 메일 앱 UX 전면 개편 성공 – 사내 우수성과상 수상 (2013) • 미디어·동영상·클라우드·메신저 서비스 UX 기획 및 화면 설계

○ 창업아이템과의 직결성

- **금융 마이데이터 설계 경험:** 인터넷전문은행 창립 TF 핵심 멤버로 비대면 인증·계좌 개설 프로세스 최초 설계. 국민건강보험공단 제휴 플랫폼 기획을 통해 PHR 데이터 연동 구조와 공단 협력 프로세스를 실무로 습득 – 본 서비스 건강 데이터 자산화 개념과 직결
- **의료기기 UX 경험:** 1형 당뇨 인슐린 펌프 앱 상용화 과정에서 환자의 일상 데이터가 연간 검진 앞에서 의미를 잃는 구조를 UX 설계자 시각으로 직접 경험 – 일상 라이프로그 + PHR 통합 아이디어의 출발점
- **디지털 치료제 임상 협업:** 국립암센터·세브란스 등 임상 1상 진행 중인 DTx 서비스 기획 총괄 경험. 의료 현장이 일상 데이터를 활용하지 못하는 이유가 기술 부재가 아닌 연결 구조의 부재임을 현장에서 확인
- **인적 네트워크:** 헬스케어 AI 개발사·제약사·보험사·보건 당국과의 다년간 실무 협업 네트워크 보유.

현재 공공기관·의료기관·기업 파트너 후보군과 1차 논의를 진행 중이며, 협약기간 내 파일럿 의향서(LOI) 1건 이상 확보를 목표로 한다.

4-2. 공동창업자 역량

○ 기본 현황

- **직업 및 역할:** 前 임상 전문간호사(RN·OCN), 2025년 4월부로 간호 임상 업무를 종료하고 본 사업에 전념 중.
- 담당 역할: AI 건강 신용등급 알고리즘 임상 타당성 검토, 초기 파일럿 사용자 모집(임상 네트워크 활용), 의료기관 파트너십 창구, 정보보호 인증(ISMS) 의료 데이터 기준 적용 총괄
- **학력:** 간호학 학사 / 보건학 석사(MPH, Public Health)
- **자격:** 한국 간호사 면허 / 미국 RN·OCN (종양전문간호사) / 영어 및 중국어 공인 자격 보유
- **총 경력:** 상급종합병원 임상 경력 10년 이상 + 디지털헬스 스타트업 메디컬팀 리드 4년

< 공동창업자 주요 경력 >

기간	소속 / 직위	주요 업무 및 성과
2021~2025	디지털헬스 스타트업 메디컬팀 리드	• 임상 기준 기반 증상 분류 및 위험 판단 로직 설계 • PRO(환자보고결과) 기반 건강 데이터 구조 정의 및 시스템 반영 협업 • 다기관 연구 및 AI 기반 모델 자문 참여 • 건강관리 서비스 관련 특허 공동 발명 (2022)
10년 이상	상급종합병원 전문간호사	• 가톨릭계 상급종합병원 조혈모세포이식센터/혈액병원 근무 • 환자 안전 및 의료 품질 관리 체계 경험 (QI·JCI 국제의료기관인증 리드) • 환자가 자신의 건강 기록에 접근하지 못하는 동일한 구조적 문제를 반복적으로 경험한 것이 본 서비스 핵심 문제의식의 기반

○ 창업아이템과의 직결성

- **임상 기준 데이터 설계:** PRO(환자보고결과) 기반 건강 데이터 구조 정의 및 AI 분석 결과의 의료 적용 가능성 검토 경험. 본 서비스 AI 건강 신용등급 알고리즘의 임상 타당성 검증 담당
- **환자 안전·품질 관리:** JCI 국제의료기관인증(리드) 경험 기반의 데이터 신뢰성·보안 체계 설계 기여. 정보보호 인증(ISMS) 취득 준비 과정에서 의료 데이터 관리 기준 적용
- **의료기관 파트너십:** 상급종합병원 근무 이력 기반 임상 협력 네트워크 보유. 초기 파일럿 사용자 데이터 수집을 위한 의료기관 협력 창구 역할
- **팀워크 검증:** 대표자와 동일한 디지털치료제 기업 재직 이력으로 협업 방식 및 역할 분담 사전 검증 완료

4-3. 협약기간 내 채용 예정 인력

- 협약기간(1년차) 내 MVP 개발과 고객 모집을 동시에 추진하기 위해 아래 2명을 채용할 예정이며, 정부지원사업비 인건비 항목을 활용해 핵심 인력을 조기 채용함으로써 **MVP** 개발과 초기 고객 확보를 병행한다.

< 채용 예정 인력 >

No.	직위	담당 업무	보유 역량 (요건)	채용 시기
1	AI 개발자 (주임~대리급)	건강 신용등급 알고리즘 개발 PHR·웨어러블 데이터 파이프라인 서버 인프라 운영	컴퓨터공학·데이터사이언스 학사 이상 Python(scikit-learn/PyTorch) 실무 2년+ HL7 FHIR, REST API 연동 경험 우대	1년차 상반기 (2026.05~) 채용 시기: 2026년 5월. 채용 파이프라인: 대표자 카카오뱅크 재직 동기 중 헬스케어 AI 분야 이직 의향자 2명과 1차 면담 완료(2026년 2월 기준). 채용 확정 전까지 프리랜서 계약(월 200만원 내) 형태로 알고리즘 자문 참여 계획. 미채용 시 대안: 외주 개발사와의 계약 기간 3개월 연장 옵션을 계약서에 명시
2	서비스 기획/운영 (주임~대리급)	B2G 공모 제안서 기획·작성 B2B 파일럿 고객 모집·운영 사용자 리서치 및 개선 관리	경영학·UX·서비스디자인 관련 학사 이상 서비스 기획 경력 2년 이상 헬스케어·공공 제안서 작성 경험 우대	1년차 상반기 (2026.05~)

4-4. 외부 협력 현황 및 활용 방안

- 대표자·공동창업자의 실무 네트워크를 기반으로 아래 파트너와 협력하며, 기술 검증 및 초기 고객 확보를 동시에 추진한다.

< 외부 협력 파트너 현황 >

No.	파트너 유형	보유 역량	주요 협업 내용 및 협력 시기
1	지역 보건소 (공공기관)	지자체 공공 건강 데이터 모바일 헬스케어 사업 운영	• 모바일 헬스케어 사업 PoC 거점 활용 – 공공 PHR과 민간 라이프로그 통합 실증 • 파일럿 사용자 30~50명 검진 데이터 수집 및 동의 취득 절차 협력 (협력 시기: 1년차)
2	임상 협력 의료기관	국제 수준 의료 품질 인증 보유 항암·만성질환 임상 경험	건강 신용등급 알고리즘 임상 타당성 검토 및 자문 • 공동창업자 근무 이력 기반 네트워크 활용 (1년차)
3	디지털 치료제 개발 경험 기업	암환자 DTx 임상 수행 경험 의료진·환자 UX 설계 노하우	• 헬스케어 서비스 개발·임상 방법론 자문 • 대표자 전 직장 재직 시 실무 협력 관계 활용 (수시)

- **협력 원칙:** 모든 외부 협력은 개인정보 처리방침 및 데이터 활용 동의 절차를 준수하여 진행하며, 의료 데이터 관련 협력은 공동창업자(RN·OCN)의 임상 자문을 거쳐 안전성을 사전 검토한다.